Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Autos: 0827890-04.2019.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Erro Médico
Autor:Luana Sarmento Cabanha Jebaili
Réu: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul

Vistos...

Luana Sarmento Cabanha Jebaili ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor da **CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul**.

Em 1º/02/2018, deu entrada no pronto socorro da parte requerida, por meio do convênio médico São Francisco Saúde, com sintomas de fortes dores abdominais.

Solicitaram exames de sangue, urina, tomografia completa de abdômen e ressonância magnética, diagnosticando infecção urinária, com prescrição de tratamento com antibiótico por sete dias.

Em 21/02/2018, ainda sentindo fortes dores abdominais, retornou ao pronto socorro e lhe solicitaram novos exames de sangue, urina e raio-x de abdômen, os quais indicaram a presença de pedra nos rins, de forma que foram prescritos antibióticos.

Em 1º/03/2018, com a piora severa de seu quadro clínico, viu-se obrigada a retornar ao pronto socorro para novo atendimento de urgência.

Em decorrência dos seguidos equívocos de diagnóstico, seu quadro clínico tornou-se extremamente grave e penoso, e foi parar no pronto socorro em estado de inconsciência, com perda dos sentidos, desmaios frequentes, vômitos e evacuações involuntárias, causadas pela extrema dor na região abdominal, episódios que foram tratados pelos médicos como crise histérica.

Os médicos chegaram ao ponto de jogar água fria em seu rosto para acordar dos desmaios frequentes; e ainda trocaram suas vestes sujas na frente dos demais pacientes que estavam no local - situação extremamente vexatória.

Inexistem registros em seu prontuário acerca da verificação de seus sinais vitais (pressão arterial, pulso, temperatura e frequência respiratória), quando de sua chegada no pronto socorro em 1º/03/2018, o que leva a concluir que tais medidas básicas não foram observadas pelos prepostos da parte requerida.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Extrai-se do Parecer Técnico, elaborado com base em seu prontuário médico, que os desmaios tratados como crise histérica, era baixo fluxo cerebral – pressão arterial não verificada em nenhuma oportunidade, demonstrando evidente imperícia dos prepostos da parte requerida, os quais sequer aferiram seus sinais vitais.

Após ser medicada com morfina e ser submetida à oxigenioterapia, fora atendida por um ginecologista obstetra, que a diagnosticou com gravidez ectópica; e, ao perceber o gravíssimo erro de diagnóstico inicial, comunicou o primeiro profissional que a atendeu em 1º/02/2018.

Realizado ultrassom e constatada intensa hemorragia interna, fora encaminhada para cirurgia de emergência, com transfusão de sangue pela constatação de anemia normocrômica e normolítica.

Apesar da situação emergencial, forte dor e quadro clínico grave, foi obrigada a esperar o médico cirurgião responsável para ser submetida ao tratamento necessário, sendo que fora suspensa a transfusão sanguínea.

De acordo com o parecer técnico, a “transfusão sanguínea [...] não deveria ser suspensa, pois a queda do hematócrito e hemoglobina já denunciavam que era quadro de hemorragia grave", o que fora comprovado com o hemograma realizado no pós-operatório.

No decorrer do procedimento cirúrgico, sofreu uma parada cardíaca devido à hipóxia tecidual por anemia e hipotensão arterial, ou seja, a parada cardíaca poderia ter sido evitada se a primeira transfusão de sangue não houvesse sido suspensa, o que foi comprovado por meio do hemograma, em que se constatou a gravidade do seu estado de saúde, tanto que a submeteram a nova transfusão.

Foi privada do oxigênio, vital ao funcionamento celular, por redução da hemoglobina carreadora do gás vital, por 36 horas, sendo mais um erro cometido pela parte requerida.

Suplicou pelo auxílio do Poder Judiciário, a fim de ser reparada pelos danos morais suportados em decorrências dos inúmeros infortúnios vivenciados e pelos gravíssimos erros de diagnósticos, os quais a submeterem a situação de extrema dor e humilhação, a impossibilitaram de cuidar de seu filho em idade de extrema dependência materna, e indiretamente contribuíram para a rescisão de seu contrato de trabalho.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Por isso, pediu (f. 27): (...) d) Julgar PROCEDENTE "*in totum*" os pedidos da presente ação, a fim de condenar o Requerido a indenizar a Requerente pelos danos morais suportados, em valor a ser sabiamente arbitrado por este Douto Juízo, indicando para tanto o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA/Índice Nacional de Preços ao Consumidor, aplicando-se juros de mora desde a data da citação; *(Sic)*

Juntou documentos (f. 29-195).

Conciliação infrutífera (f. 208).

A parte requerida contestou (f. 212-229) e disse inexistir prova de negativa, ausência de cuidado, descaso, negligência ou imperícia. Ao contrário, autorizou todos os procedimentos solicitados pela parte requerente e lhe forneceu os melhores tratamentos, desde a primeira internação.

O laudo pericial apresentado pela parte requerente está eivado de erros e afirmações falsas, todas comprovadamente impugnadas por meio de transcrições do prontuário médico da paciente.

O perito que elaborou o laudo para a parte requerente cometeu erro grave ao afirmar que não foi verificado os sinais vitais da paciente quando da sua admissão no hospital Cassems, considerando a inveracidade da informação.

Ao contrário do alegado na inicial, em que se disse que a parte requerente foi classificada como "histérica", foi verificado que a paciente estava cianótica e com sudorese, de maneira que foram realizadas todas as providências adequadas e medidas terapêuticas necessárias e indicadas para o caso.

A parte requerente aduziu que lhe fora administrada morfina no primeiro atendimento, mas o prontuário indica que seria administrada apenas se necessário, e não foi o caso.

Ao ser atendida em 1º/02/2018, a equipe médica realizou exames e identificou um quadro de infecção urinária. Retornou ao hospital, em 1º/03/2018, com quadro clínico compatível com o de abdômen agudo hemorrágico, e foram tomadas as medidas clínicas para estabilização do quadro, ou seja, dois acesso venosos, reposição volêmica e, posteriormente, exames de imagem que diagnosticaram a gravidez ectópica, sendo submetida a cirurgia de urgência para a realização de salpingectomia (retirada da trompa uterina onde estava ocorrendo a gestação ectópica).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Os registros médicos comprovam que a parte requerente foi encaminha para acomodação coletiva, no 6º andar do Hospital CASSEMS, recebendo transfusão sanguínea no dia seguinte ao procedimento, não sofrendo qualquer sequela.

É inconcebível que uma paciente que sofra para cardíaca durante uma cirurgia não seja encaminhada para a UTI no pós operatório.

O parecer elaborado pelo *expert* demonstra que a afirmação de parada cardíaca durante o procedimento cirúrgico é falsa, ou seja, não ocorreu parada cardíaca por atraso na transfusão sanguínea.

Por fim, diante da falta de responsabilidade pelo ocorrido, pugnou pela improcedência do pedido.

Anexou documentos (f. 230-444).

Réplica com juntada de documentos (f. 446-469).

Saneador com o afastamento das preliminares (f. 479-483).

Juntada do laudo pericial (f. 549-560 e 585-588); manifestação das partes (f. 563-566, 567-572, 589-590, 593, 595-598); audiência de instrução e julgamento (f. 634); e alegações finais pela procedência e improcedência, respectivamente (f. 639-643 e 644-646).

É o relatório. Passo a decidir.

Para o julgamento da causa, o juízo delimitou a atividade probatória e distribuiu o ônus da prova (f. 479-483):

> **Fato 1 –** Que houve sucessivos erros no diagnóstico na autora: inicial, feito em 01/02/2018, como sendo quadro de infecção urinária, retificado, posteriormente, em 21/02/2018, por possível pedras nos rins, quando na verdade, em 01/03/2018 descobriu-se que a autora tinha gravidez ectópica, sendo encaminhada para cirurgia de emergência.
>
> **Fato 2 –** Que ao ingressar no pronto socorro requerido em 01/03/2018 a autora foi tratada como em crise histérica e teve suas vestes trocadas em meio aos demais pacientes que estavam no local.
>
> **Fato 3 –** Que não houve aferição dos sinais vitais da autora quando da sua entrada no pronto socorro em 01/03/2018 e que a ela foi ministrada morfina quando não era necessário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.

Fato 4 – Que houve suspensão da transfusão de sangue na autora, também de forma indevida, e em razão do que a autora teve parada cardíaca.

Fato 5 – Que em razão dos fatos, a autora se privou aos cuidados do seu filho que contava com 1 ano e 6 meses ao tempo dos fatos, assim como, teve seu contrato de trabalho rescindido.

Embora tenha sido reconhecida a aplicação das normas do CDC à relação jurídica existente entre as partes, verifico que a questão dos autos é substancialmente regulada pelo Código Civil, nos arts. 186 e 927, porquanto refere-se à pretensão à reparação por danos morais, portanto, responsabilidade civil extracontratual, fundada na possível prática de ilícito.

Diante disso, mantenho a regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, cabendo à autora comprovar os pressupostos legais à reparação por danos morais, e à requerida, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos deste direito.

Em audiência, colheu-se as informações de Marco Antonio de Souza (f. 634/áudio), esposo da parte requerente:

Disse que a levou por três vezes ao hospital. Na primeira consulta fez exames e constatou infecção urinária. 15 a 20 dias depois, ainda com dores, voltaram ao hospital e o médico pediu ultrassom de rim. O médico perguntou se tinha implante de DIU, o que foi negado. Passou mais remédios e voltaram para casa. Alguns dias depois encontrou a esposa com a boca roxa, quase desfalecida e a levou para o hospital. Colocaram a parte requerente na cadeira de rodas. Não estava desfalecida. Ao perceber que a esposa estava mal, pediu ajuda e depois de meia hora uma mulher saiu com sua esposa. Veio outra enfermeira dizendo que a parte requerente estava histérica. A enfermeira trouxe um copo de água, e jogou no rosto da parte requerente. Perguntou se era procedimento normal. Trocaram a roupa de sua esposa na frente das pessoas que estavam no local. Cortaram a roupa porque a parte requerente tinha evacuado nas vestes. Chegou um médico, que cruzou os braços e perguntou o que estava acontecendo. Contou os fatos ao médico que saiu e não voltou mais. Deram remédio para dor. Em seguida veio outro médico, perdido, a enfermeira disse que tinha dado morfina para a parte requerente e a dor não passava. Não sabe como foi aplicada a morfina, acredita que foi intravenosa. Outro médico apareceu, era o primeiro que a atendeu quando foi diagnosticada com infecção urinária. Depois do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.

atendimento, o médico disse que tinha havido um problema, mas que iria resolver. Apareceu uma médica que pediu um ultrassom. Ao fazer o ultrassom ouviu os médicos dizer que havia sangue e deu gravidez ectópica. Os médicos não explicaram nada. Em seguida, montaram uma UTI no local porque não podiam mover a parte requerente. Fizeram uma cirurgia para estancar a hemorragia e retirar o feto da gravidez ectópica. Teve que fazer transfusão de sangue por causa de uma anemia forte e tomar ferro. Depois da cirugia, a parte requerente perdeu o emprego, pois a política da empresa era de não aceitar a apresentação de atestados médicos. A parte requerente não moveu ação trabalhista contra a empregadora. A parte requerente, no período de março a dezembro, não saía de casa, só ficava dentro do quarto. Nesse período teve que tomar conta da casa e do filho. Teve depressão e até hoje toma medicação controlada. A vida sexual, emocional e financeira do casal acabou. Por causa da depressão a parte requerente engordou e teve que fazer cirurgia bariátrica. Nunca perguntaram se a parte requerente estava gestante.

Pois bem.

Fato 1 – Que houve sucessivos erros no diagnóstico na autora: inicial, feito em 01/02/2018, como sendo quadro de infecção urinária, retificado, posteriormente, em 21/02/2018, por possível pedras nos rins, quando na verdade, em 01/03/2018 descobriu-se que a autora tinha gravidez ectópica, sendo encaminhada para cirurgia de emergência.

O perito judicial elaborou o laudo e referendou (f. 552):

"Nos atendimentos de 01 e 21/02/2018, aos quais a autora buscou o Hospital Réu, não haviam queixas da paciente que indicassem possível gestação ectópica (GE), inclusive no prontuário há relato de que a mesma negou possível gravidez. A paciente não foi desassistida nas oportunidades em que buscou o hospital, sendo realizadas as medidas possíveis na unidade de emergência, com realização de medicações e exames conforme prescrições. Todos exames complementares realizados até então não tiveram alterações significativas ou que indicassem GE. Outro ponto a ser discutido é que a paciente não buscou atendimento ambulatorial para investigação de doença no mês de fevereiro (soa de maneira controversa a paciente permanecer um mês inteiro com dores e não buscar atendimento em posto de saúde para investigação ou consulta com outro especialista)."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.

Portanto, o que se extrai do laudo é que não ocorreu erro no diagnóstico da parte requerente, ou seja, a equipe médica realizou os procedimentos e exames de acordo com a queixa inicial, não restando comprovado o fato constitutivo de seu direito.

Fato 2 – Que ao ingressar no pronto socorro requerido em 01/03/2018 a autora foi tratada como em crise histérica e teve suas vestes trocadas em meio aos demais pacientes que estavam no local.

> O informante Marco Antonio de Souza (f. 634/áudio), esposo da parte requerente, realçou que durante o último atendimento, levou a esposa desfalecida ao hospital, e uma enfermeira disse que a parte requerente estava histérica. Depois, pegou um copo de água, e jogou no rosto da parte requerente. Salientou que por ter evacuado nas vestes, as enfermeiras trocaram a parte requerente na frente das pessoas que estavam no local.

Apesar de tais declarações, inexistem outras provas aptas a corroborar o descaso da equipe médica com a situação da parte requerente, de modo que não há como afirmar que ocorreram como retratado pelo informante.

Fato 3 – Que não houve aferição dos sinais vitais da autora quando da sua entrada no pronto socorro em 01/03/2018 e que a ela foi ministrada morfina quando não era necessário.

O perito do juízo afastou a alegativa da parte requerente quanto a não aferição dos sinais vitais, porquanto enfatizou (f. 552):

> "No dia 01/03/2018, a paciente chegou no PS do Hospital CASSEMS com sinais de choque hemorrágico. Foram aferidos os sinais vitais às 02h45min e identificados clinicamente sinais de choque, tais como cianose e sudorese. Após estabilização da paciente, foram realizados exames de imagem que confirmaram a suspeita clínica de gestação ectópica. No hemograma realizado em 01/03/2018, anterior ao procedimento cirúrgico, não havia indicação para realização de transfusão sanguínea (Hb 8,9g/dl). Em novo exame, após o procedimento, no período noturno houve a indicação da realização, sendo administradas duas bolsas na madrugada."

Quanto a aplicação de morfina, também não restou comprovada a sua utilização, conforme declaração do perito (f. 554):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.

"6. Poderia o Ilustre Perito explicar ao Excelentíssimo Juiz o significado das siglas ACM e SN em prescrições médicas? Na prescrição médica de 01/03/18, das 02:46hr, folhas 246, a medicação morfina estava prescrita como? Foi administrada? R: ACM = "a critério médico"; SN = "se necessário". Prescrita Dimorf 10mg ACM. **Não foi checada a administração, logo provavelmente não foi administrada**."

Fato 4 – Que houve suspensão da transfusão de sangue na autora, também de forma indevida, e em razão do que a autora teve parada cardíaca.

O perito declarou que houve a suspensão da transfusão de sangue, porque a paciente foi para o centro cirúrgico (f. 557):

"14. Por que foi suspensa a transfusão de sangue quando a paciente tinha sinais francos de choque hipovolêmico por sangramento? Justifique. R: Houve prescrição de concentrado de hemácias por anestesista do centro cirúrgico, às 10h01min, porém o mesmo foi suspenso antes do momento da cirurgia. Em último hemograma disponível (com resultado liberado às 10h54min) o valor da hemoglobina estava em 8,9g/dl. Usualmente a transfusão de urgência ocorre em valores iguais ou inferiores a 7g/dl, logo, este foi o motivo da suspensão. No período da noite, ao ser checado novo hemograma liberado às 18h18min, a hemoglobina da paciente estava em 7,0g/dl, sendo então prescritas duas unidades de Concentrado de Hemácias (houve a transfusão).

Em relação à parada cardíaca, o perito contou que a parte requerente não teve parada cardíaca durante a cirurgia (f. 552):

"Não houve parada cardíaca durante a cirurgia de acordo com as informações constantes em prontuário médico, não foi demonstrada essa intercorrência em prontuário."

Fato 5 – Que em razão dos fatos, a autora se privou aos cuidados do seu filho que contava com 1 ano e 6 meses ao tempo dos fatos, assim como, teve seu contrato de trabalho rescindido.

O informante Marco Antonio de Souza (f. 634/áudio), esposo da parte requerente, disse que após a cirurgia a parte requerente foi demitida, e como não saía do quarto, por causa da depressão, teve que dispensar cuidados ao filho do casal.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.

Apesar de grave situação a que fora acometida a parte requerente, não há como atribuir a culpa de sua depressão à parte requerida, pois, como se vê do laudo pericial, não houve erro no diagnóstico.

Também não é possível dizer que a parte requerida é a responsável pela demissão da parte requerente, mesmo porque se fora demitida por causa dos atestados médicos, caberia ingressar com ação trabalhista, já que o direito à saúde é amparado pela Constituição Federal e pela CLT.

Ademais, a parte requerente não poderia ser demitida exclusivamente porque estava afastada por atestado médico, e como se extrai da declaração do informante, a parte requerente não ingressou com ação trabalhista.

Nesse contexto, considerando as provas dos autos e, principalmente, o laudo pericial (f. 549-560), não há como afirmar que houve erro médico nos atendimentos prestados à parte requerente, antes do diagnóstico de gravidez ectópica, como também não restou evidenciada qualquer sequela permanente ou incapacidade laborativa secundária.

Aliado a isso, o perito referendou que dos documentos analisados não se constatou indícios de negligência, imperícia ou imprudência da equipe médica.

Assim, considerando que a responsabilidade civil decorrente de erro médico é de natureza subjetiva, inexistindo prova da conduta culposa da equipe médica e o nexo de causalidade com o dano experimentado, não há falar em condenação por danos morais (CPC, art. 373, I):

> (...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o hospital possui responsabilidade objetiva e solidária por erro ocorrido com culpa de médico integrante de seu corpo clínico, adotando o disposto no art. 932 do Código Civil, sendo que, no entanto, não dispensa a verificação da culpa por parte do médico, que possui responsabilidade subjetiva. 2. Não há nada nos autos que evidencie que, pela natureza do quadro da paciente, os médicos deveriam ter agido de modo diverso e que os danos poderiam ser evitados ou reduzidos, o que mostra-se clara a ausência de ato ilícito e nexo causal, logo não como responsabilizar os requeridos pelos danos morais e estéticos reclamados na inicial, sendo então irrepreensível a sentença de improcedência dos pedidos. *(TJMS; AC 0826796-55.2018.8.12.0001; Campo Grande; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 07/08/2023; Pág. 74)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido de danos morais.

Sucumbente, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 12% sobre o valor da causa, atualizado pelo IGPM, desde a propositura da demanda, atento às diretrizes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo tempo de trabalho do causídico e a alta complexidade do feito. Porém, suspendo tais exigibilidades por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Quanto aos honorários periciais, por ser a parte requerente beneficiária da gratuidade, deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, por ROPV, após trânsito em julgado da sentença, com atualização na forma do Tema de Repercussão Geral 810.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande, *(data e assinatura à margem direita do documento).*

Marcus Vinícius de Oliveira Elias
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 21/09/2023 às 14:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0827890-04.2019.8.12.0001 e código LIrdlOo0.